Ministério da Saúde

Urgencia Nº: [redacted] **Data Urg.:** 10-Ago-2023 [redacted]

Identificação

Proc.: [redacted] N. Utente: [redacted]

Nome: [redacted]

Data Nasc.: 01/05/1967 **56 Anos** Sexo: Masc. Casado

Morada: [redacted]

Localidade: [redacted] Telefone:

Médico Familia

Centro de Saúde: USF FERNAO MAGALHAES

Médico:

Outros Dados

Causa : DOENCA

Isento Taxa (76)

Subsistema: SNS Nº. [redacted]

Observações: SO

Proveniência: INEM

Ultima urgencia em: 14/06/2023 - 57 Dias

Triagem

Data / Hora da Triagem: 10/08/2023 02:17:55 **Fluxograma :** (19) 19 - Dor abdominal

Discriminador: Dor moderada

Prioridade Clínica

Urgente (Amarelo)

Temperatura: 36.6 °C **Dor:** 6 **Glasgow:**

PEFR: **Freq. Resp.:** **PA:** /

Glicémia: **Corpos cetónicos:** **Freq. card.:** **Ritmo de pulso:**

Oxi. per.:

Mobilidade: Em maca

Especialidade: HUC-URG CIRURGIA GERAL **Grupo:** Huc-Urgencia **Sala:** HUC-ESPEC CIRURGICAS

Queixa: Dor abdominal hoje

Justificação Via Verde:

Triador: Enf. JOSE MIGUEL FERREIRA CRISTO **Nº. Mecanográfico:** 9633 **Ass.:** _____

Observações Médicas

10-Ago-2023 02:52:00 Dr. JOSE FILIPE MELO / HUC-URG CIRURGIA GERAL

Homem, 56 anos

Homem com episódio de vários vómitos tipo água, sem tolerância alimentar. Dor abdominal desde hoje pelas 11h muito intensa e em crescendo. Nega alteração do trânsito.

MH:
Lantus
Dulaglutida
Rosuvastatina+Ezetimibe
Candersartan
Ramipril

EO:Doente muito queixoso
T 37.3ºC
Abdomen distendido com pequena hérnia umbilical redutivel indolor presente, abdomen doloroso nos quadrantes direitos principalmente no hipocôndrio esboçando SIP
Murphy Renal negativo

GSA aa: pH 7.528; pCO2 28.1; pO2 86,4; HCO3 22.8; Na 131,8; K 4.18; Lac 1,6; Hb 15,5

Plano:
Peço análises
Faz analgesia + fluidoterapia
Peço Eco + Rx

10-Ago-2023 10:27:00 Dr. INES PRIOR / HUC-URG CIRURGIA GERAL

AN: Cr 0.89 Na 130 PCr 1.59 Leuc 14.3 coag ok

Eco abd:
Vesícula biliar distendida e com múltiplos ecos em suspensão e na região do fundo um aspecto hiperecogénico, admitindo-se a hipótese de colecistite enfisematosa. Há discreto espessamento parietal. Presença de pequenos focos litiásicos. Fígado sem alterações ecográficas. Não há dilatação das vias biliares nem da veia porta. Pâncreas não visualizado. Baço sem alterações ecográficas. Rins sem sinais de uropatia obstrutiva. Não é evidente derrame peritoneal.

Rx Abd:
Distensão colica aparente no hipocondrio esquerdo.
Sem NHA, fezes dispersas no colon.

REAVALIAÇAO.
TA 171/100mmHg
FC 111bpm
Sat 97% em aa
Dor abdominal ++ hipocondrio direito, com Murphy vesicular duvidoso, dor a descompressao.

Doente refere moinha no hipocondrio direito que cessou no fim desse dia. Dor recomeçou novamente ontem.

Nega alergias medicamentosas.

Portanto:
Suspeita de Colecistite Aguda em doente diabetico

Inicia ATB
Peço rotinas pre op.
Peço classificação.
Reforço analgesia e fluidoterapia.

10-Ago-2023 11:18:23 Dr. INES PRIOR / HUC-URG CIRURGIA GERAL

Vaga de internamento na enfermaria C

Assino consentimento informado para cirurgia.
Aguarda tempo cirurgico para intervenção.

Glicemia de 300 cetonemia

Contacto endocrinologia para ajuste terapeutico.
Inicia insulina rapida.

10-Ago-2023 12:03:35 Dr. INES HENRIQUES VIEIRA / HUC-URG ENDOCRINOLOGIA

ENDOCRINOLOGIA

Pedido de colaboração por hiperglicemia com cetonémia elevada em doente proposto para colecistectomia urgente.

Trata-se de doente com diabetes mellitus tipo 2, previamente medicado com lantus e iGLP1 Refere ainda fazer outros fármacos para a DM, ms que não estão no verbete de urgência e não sabe referir, encontro prescrição de Empagliflozina.
Veio por "vários vómitos tipo água, sem tolerância alimentar. Dor abdominal desde hoje pelas 11h muito intensa e em crescendo. Nega alteração do trânsito."

GSA aa à entrada: pH 7.528; pCO2 28.1; pO2 86,4; HCO3 22.8; Na 131,8; K 4.18; Lac 1,6; Hb 15,5

analiticamente 2023-08-10
hb 15.4; leuc 14.3; plaq 230
glic 375; cr 0.89; Na 130; k 4.4; CK 94; prot tt 7.6; Alb 4.4; Ca 9.9; Osm 278; provas hepáticas ok, mas BRB 1.5; PCR 1.59

prescritas já 10U de rápida

à minha obs

- glic 340; cetonémia 3.2

Contexto de vómitos a contribuir para valor de cetonémia, mas doente para cirurgia de urgência, a aguardar sala. Previamente sob empagliflozina que idealmente deve ser suspensa 4 dias antes de procedimentos, não tendo sido possível neste caso.
Opto por iniciar perfusão.
Aviso equipa de enfermagem e deixo esquema impresso. Deixo tb na tabela de internamento para o pós-op imediato a menos que alterações que impliquem mudança

Notas de Enfermagem

Diagnósticos

(K8000) - Litíase vesícula biliar, c/colecistite aguda, s/obstrução — Diagnostico Principal

Dr(a). Ines Prior — 10-08-2023

Medicação

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Metamizol magnésico 2000 mg/5 ml Sol inj Fr 5 ml IM IV

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Metoclopramida 10 mg/2 ml Sol inj Fr 2 ml IM IV

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Cloreto de sódio 9 mg/ml Sol inj Fr 500/1000 ml IV

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Ondansetrom 8 mg/4 ml Sol inj Fr 4 ml IV

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | | 10/08/2023 | CIPROfloxacina 200 mg/100 mL Sol inj Fr 100 mL IV

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | | 10/08/2023 | Paracetamol 10 mg/ml Sol inj Fr 100 ml IV

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | Pantoprazol 40 mg Pó sol inj Fr IV

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco
10/08/2023 | | 10/08/2023 | Cloreto de sódio 9 mg/ml Sol inj Fr/Sac 1000 ml IV

Medicação

Data Início	Data Fim	Data da última toma	Designação do Fármaco
10/08/2023		10/08/2023	Insulina humana (solúvel) 100 U.I./ml Acção curta Sol inj Cartu 3 ml IM IV SC

MCDT Requisitados / Procedimentos Efectuados

Código		Descrição	Código		Descrição
Z99240	2	DETERMINAC?O GLICEMIA CAPILAR	Z99220	2	AVALIAC?O DE SINAIS VITAIS (PULSO, TEMPERATURA E TENSAO ARTERIAL)
Z99320	1	COLOCACAO DE SONDA NASOGASTRICA	I80270	1	OXIMETRIA DE PULSO
M10405	1	TORAX 1 INCIDENCIA	C40301	1	ECG SIMPLES DE 12 DERIVACOES COM INTERPRETACAO E RELATORIO
M11010	1	ABDOMEN SIMPLES 1 INCIDENCIA	M17130	1	ECOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR
A21513	1	CLORETOS, S/U/L	A24359	1	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO (APTT), S
A88888	1	OUTRAS	A21340	1	BILIRRUBINA TOTAL, S/L
A21220	1	AMINOTRANSFERASE DO ASPARTATO (AST), S	A22035	1	GAMAGLUTAMIL TRANSFERASE (GGT), S
A21609	1	CREATINAQUINASE (CK), S	A22679	1	PROTEINAS TOTAIS, S/U/L
A55025	1	FENOTIPAGEM ERITROCITARIA RH E KELL	A22671	1	PROTEINA C REACTIVA ULTRASENSIVEL, S
A24347	1	TEMPO DE PROTROMBINA, S	A55056	1	PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, ANTI-ERITROCITO (EM MEIO ENZIMATICO)
A21344	1	BILIRRUBINA DIRETA, S/L	A22949	1	UREIA, S/U
A55010	2	TIPAGEM ABO E RH	A21665	1	DESIDROGENASE LACTICA (LDH), S/U/L
A21935	1	FOSFATASE ALCALINA, S	A21396	1	CALCIO TOTAL, S/U
A21140	1	ALBUMINA, S	A55057	1	PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, ANTI-ERITROCITO (MEIO DE ANTIGLOBULINA HUMANA), EM DOE
A22617	1	POTASSIO, S/U	A22076	1	GLUCOSE, DOSEAMENTO, S/U/L
A21620	1	CREATININA, S/U	A24209	1	HEMOGRAMA COM FORMULA LEUCOCITARIA (ERITROGRAMA, CONTAGEM DE LEUCOCITOS, CONTAGEM DE PLAQU
A22793	1	SODIO, S/U	A21217	1	AMINOTRANSFERASE DA ALAMINA (ALT), S

Destino do Doente

Data : 10-Ago-2023 14:58:00

Destino : 3 - SERVICO DE INTERNAMENTO - HUC-CIRURGIA GERAL

Médico : 68112 - DR. INES PRIOR **Assinatura :** _____